

Trombose venosa profunda · diagnóstico e anticoagulação

TVP proximal exige anticoagulação pronta se não houver contraindicação. Use probabilidade pré-teste + USG; trombólise/filtro de VCI são exceções.

Proximal × distal

Lembre - Proximal × distal

Íliaco-femoral-poplítea: tratar. Distal isolada: pode observar com USG seriado em baixo risco ou anticoagular conforme sintomas/extensão — bancas variam; priorize proximal.

Baixa probabilidade pode usar D-dímero; alta vai à imagem e anticoagulação.

Suspeita de TVP

Wells -> exame -> tratar



Conduta

- Anticoagulação "e3 meses na provocada; mais longa se não provocada/recorrente/câncer
- DOAC preferencial em muitos cenários ambulatoriais elegíveis
- Gestação: HBPM (sem DOAC/varfarina no 1ºT conforme regra)
- Filtro de VCI: contraindicação à anticoagulação ou falha documentada

Sinais e fatores

Item | Exemplos

Clínica | Edema assimétrico, dor, cordão, calor

Provocadores | Cirurgia, imobilização, câncer, viagem longa

Exame | USG compressivo duplex

Complicação | TEP, síndrome pós-trombótica

Armadilha de prova

Atencao - Armadilha de prova

Não massageie a perna nem atrase anticoagulação esperando 'confirmação perfeita' em alta probabilidade com USG positivo. Investigar câncer oculto de forma dirigida, não painel cego universal.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1